جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : اشرف محمد محمد منصور
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** البساتين **العنوان :** --
رقم البطاقة : 26809070103658 **رقم التليفون :** 01005898280 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 18-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 07-09-1968 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان البنكرياس
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان البنكرياس
خطة العلاج : أورام كيماوي علاج تدعيمي وتلطيفي [6287] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: اشرف محمد محمد منصور
National ID: 26809070103658

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

A patient of pancreatic cancer for Supportive and palliative Treatment

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

National ID From
[DOCUMENTED FOR VVT]

Tension

T Thickness

stolic Function

l Ao Root Dimensions

Valve

Valve

oid Valve

nary Valve

Side and Systolic Function

Intracardiac Masses and Effusion

DR.

National ID Card
[DOCTOR]

Function

Root Dimensions

Valve

Valve

and Systolic Function

ic Masses and Effusion

DR.

[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]
Pathology Report

Dr. Ahmed El-Habashi , MD , PhD , FIAC
Professor of Pathology;
NCI , Cairo University
International Board of Cytopathology
Fellow of International Academy of Cytology
Fellow Tulane Univ. Hospital, USA
Fellow Groningen Univ. Hospital, Holland

أ.د. أحمد حسين الحبشى
أستاذ الباثولوجى – المعهد القومى للأورام - جامعة القاهرة
بورد السيتوباثولوجى الدولى
زميل الأكاديمية الدولية للسيتولوجى
زميل جامعة تولين- نيو اورلياتز- امريكا
زميل جامعة خرونيجن- هولندا

Patient Name: أشرف محمد منصور **Gender: Male**
Age: 58 Y-O
Clinical History: Pancreatic head mass
Nature of Specimen: Pancreatic head mass, EUS FNB
Referring Prof. Doctor: Ahmed Maher/Alaa Al-Sawak
Date of Specimen Receiving: 29/8/2026 **Date of Reporting: 2/9/2026**

Surgical Pathology/ Cytopathology Report

Gross Description:
Pancreatic head mass, EUS FNB: Received were 4 unstained smears for Pap. Stain and cytologic examination, along with fragments of tan tissue in formalin. Toto in one cassette.

Microscopic Description:
Smears and sections showed fairly cellular material featuring hemorrhagic background entangling atypical predominantly large sized epithelial cuboidal to round tumor looking cells existed in clusters, acinar patterns, cords and separate forms displaying mild moderate anaplasia manifested by disturbed honey comb patterns, nuclear enlargement, high N/C ratio (1:4), anisonucleosis, irregular nuclear membrane, prominent nucleoli and conspicuous eosinophilic cytoplasm. The background showed necroinflammtory debris.

Diagnosis
Pancreatic Head Mass, EUS FNB Cytology (Smears and Cores):
Invasive adenocarcinoma, grade II, consistent with pancreatic duct origin.

Comment:
Please tightly correlate with clinical and radiological findings.

Ahmed El-Habashi, MD, FIAC

10 شارع صبرى أبو علم بجوار وزارة الاوقاف – باب اللوق – القاهرة
تليفون : 23929937 موبايل : 0166736608
E-Mail: elhabashiahmed@yahoo.com

[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]
Pathology Report

Dr. Ahmed El-Habashi , MD , PhD , FIAC
Professor of Pathology;
NCI , Cairo University
International Board of Cytopathology
Fellow of International Academy of Cytology
Fellow Tulane Univ. Hospital, USA
Fellow Groningen Univ. Hospital, Holland

أ.د. أحمد حسين الحبشى
أستاذ الباثولوجى – المعهد القومى للأورام - جامعة القاهرة
بورد السيتوباثولوجى الدولى
زميل الأكاديمية الدولية للسيتولوجى
زميل جامعة تولين- نيو اورليانز- امريكا
زميل جامعة خرونيجن- هولندا

Patient Name: أشرف محمد محمد منصور
Age: 59 Y-O **Gender:** Male
Clinical History: Abdominal lymph node in a case of advanced pancreatic cancer
Nature of Specimen: Abdominal lymph node, excisional biopsy
Referring Prof. Doctor:
Date of Specimen Receiving: 23/9/2026 **Date of Reporting:** 30/9/2026

Surgical Pathology/ Cytopathology Report

Gross Description:
Specimen received in formalin and labeled "abdominal lymph node, biopsy". It consisted of four defined nodules 0.5x0.5 cm each. with soft reddish brown cut section and fatty tissue3x2 cm..
Toto in one cassette.

Microscopic Description:
Sections showed lymph node parenchyma with preserved architecture and involvement by follicular lymphoid hyperplasia, sinus histiocytosis and medullary fibrovascular changes together with focal necrotizing inflammation. The capsule was involved by fibroinflammatory changes. The fatty tissue is free of tumor. No granuloma or neoplasia detected.

Diagnosis
Abdominal Lymph Node, Excision biopsy:
Reactive lymphoid hyperplasia.
No granuloma or malignancy detected.

PS: 2 slides enclosed.

Ahmed El-Habashi, MD, FIAC

10 شارع صبرى أبو علم بجوار وزارة الاوقاف – باب اللوق – القاهرة
تليفون : 23929937 موبايل : 0166736608
E-Mail: elhabashiahmed@yahoo.com

Sex: Male	
Procedure: M.R.C.P.	

MRCP EXAMINATION

Technique of examination:

Axial T2 WIs "Plate 1".
3D MRCP examination using MIP technique "plate 2 & 3".
No IV contrast was given.

MRI Findings:



Large pancreatic head heterogenous soft tissue mass lesion is seen measuring about 46 x 36 x 37 mm at dimensions.
The lesion is seen eliciting heterogenous signal intensity in all pulse sequences.
The lesion compressing the distal CBD with consequent moderate to marked dilatation of the proximal CBD measuring about 21 mm and consequent mild to moderate dilatation of the intra hepatic biliary radicels.
Pancreatic duct is dilated measuring about 9 mm.
Average size of the liver eliciting homogenous parenchymal texture. No focal hepatic lesions detected.
Normal appearance of the spleen, pancreas, aorta, IVC and both kidneys.
No ascites seen.
No para aortic lymphadenopathy noted.
Normal MRI appearance of the lung bases.

Conclusion:

Pancreatic head mass lesion likely neoplastic with consequent moderate to marked intra extra hepatic biliary radicles dilatation as detailed.

Bone Scan
[[DOCTYPE:BONE_SCAN]]

Ministry of Health and Population
National Hepatology & Tropical
Medicine Research Institute

وزارة الصحة
الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد
التعليمية
المعهد القومى للأمراض المتوطنة

Patient Name: ASHRAF MOHAMED MOHAMED 58Y	Patient ID: 0103658
Age:	Study Date: 10/06/2026 08:59:27 AM

02-Jul-2026
17002607020

DIGITALIZED PLAIN X-RAY EXAMINATION OF THE ERECT ABDOMEN REVEALED: -

Findings:

- Normal gaseous distribution of the bowel loops.
- No air/fluid levels detected.
- No air is seen under the diaphragm.
- No evidence of radio-opaque foreign bodies seen.

Dr Duaa Yahia

Bone Scan
[[DOCTYPE:BONE_SCAN]]

Name: الزهراء محمد محمد منصور
National ID / File No.:26809070102658
Date: 2 June 2026

ABDOMINO-PELVIC ULTRASOUND EXAMINATION

- **Liver: -**
  - Average in size measuring about 15 cm at the right MCL, displaying bright homogenous echo pattern with smooth surface with hypoechoic geographical areas fat sparing around gallbladder and portal vein.
  - No sizable focal lesions or intra hepatic biliary radicle dilatation.
  - **Portal vein** is patent and not dilated.
- **Gall Bladder: -**
  - Average distention with no evidence of stones or mud inside.
  - The wall is not thickened.
  - CBD is 5 mm in caliber.
- **Spleen: -**
  - Average in size measuring about 10 cm in its long axis, displaying homogenous echo pattern.
  - No sizable focal lesions.
- **Kidneys: -**
  - Both are of average size, normal shape, parenchymal thickness and echogenicity.
  - No gross stones or back pressure changes seen.
- No definite abnormalities of pancreatic body. The pancreatic head cannot be clearly appreciated due to gaseous distension . Prominent **pancreatic duct** (about 4 mm) is noted.
- **Colonic** gaseous distention.
- No **ascites**
- **Urinary Bladder: -**
  - Average filling with normal wall thickness.
  - No evidence of stones, or gross masses.
- **Prostate: -**
  - Average in size with homogenous echo pattern.

OPINION:

- **Bright/Fatty liver with fat sparing areas.**
- **Colonic gaseous distention.**

Bone Scan
[[DOCTYPE:BONE_SCAN]]

[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]
Pathology Report

Dr. Ahm 'l-Hab ashi , MD , PhD , FIAC
Pr 'essor of Pathology;
NCI , Cairo University
International Board of Cytopathology
Fellow of International Academy of Cytology
Fellow Tulane Univ. Hospital, USA
Fellow Groningen Univ. Hospital, Holland

أ.د. أحمد حسين الحبشى
أستاذ الباثولوجى – المعهد القومى للأورام - جامعة القاهرة
بورد السيتوباثولوجى الدولى
زميل الأكاديمية الدولية للسيتولوجى
زميل جامعة تولين- نيو اورليانز- امريكا
زميل جامعة خرونيجن- هولندا

Patient Name: أشرف محمد محمد منصور
Age: 59 Y-O **Gender:** Male
Clinical History: Abdominal lymph node in a case of advanced pancreatic cancer
Nature of Specimen: Abdominal lymph node, excisional biopsy
Referring Prof. Doctor:
Date of Specimen Receiving: 23/9/2026 **Date of Reporting:** 30/9/2026

Surgical Pathology/ Cytopathology Report

Gross Description:
Specimen received in formalin and labeled "abdominal lymph node, biopsy". It consisted of four defined nodules 0.5x0.5 cm each. with soft reddish brown cut section and fatty tissue3x2 cm..
Toto in one cassette.

Microscopic Description:
Sections showed lymph node parenchyma with preserved architecture and involvement by follicular lymphoid hyperplasia, sinus histiocytosis and medullary fibrovascular changes together with focal necrotizing inflammation. The capsule was involved by fibroinflammatory changes. The fatty tissue is free of tumor.
No granuloma or neoplasia detected.

Diagnosis
Abdominal Lymph Node, Excision biopsy:
Reactive lymphoid hyperplasia.
No granuloma or malignancy detected.

PS: 2 slides enclosed.

Ahmed El-Habashi, MD, FIAC

10 شارع صبرى أبو علم بجوار وزارة الاوقاف – باب اللوق – القاهرة
تليفون : 23929937 موبايل : 0166736608
E-Mail: elhabashiahmed@yahoo.com

[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]
Pathology Report

Dr. Ahmed El-Habashi , MD , PhD , FIAC
Professor of Pathology;
NCI , Cairo University
International Board of Cytopathology
Fellow of International Academy of Cytology
Fellow Tulane Univ. Hospital, USA
Fellow Groningen Univ. Hospital, Holland

أ.د. أحمد حسين الحبشى
أستاذ الباثولوجى – المعهد القومى للأورام - جامعة القاهرة
بورد السيتوباثولوجى الدولى
زميل الأكاديمية الدولية للسيتولوجى
زميل جامعة تولين- نيو اورليانز- امريكا
زميل جامعة خرونيجن- هولندا

Patient Name: أشرف محمد منصور
Age: 58 Y-O **Gender:** Male
Clinical History: Pancreatic head mass
Nature of Specimen: Pancreatic head mass, EUS FNB
Referring Prof. Doctor: Ahmed Maher/Alaa Al-Sawak
Date of Specimen Receiving: 29/8/2026 **Date of Reporting:** 2/9/2026

Surgical Pathology/ Cytopathology Report

Gross Description:
Pancreatic head mass, EUS FNB: Received were 4 unstained smears for Pap. Stain and cytologic examination, along with fragments of tan tissue in formalin. Toto in one cassette.

Microscopic Description:
Smears and sections showed fairly cellular material featuring hemorrhagic background entangling atypical predominantly large sized epithelial cuboidal to round tumor looking cells existed in clusters, acinar patterns, cords and separate forms displaying mild moderate anaplasia manifested by disturbed honey comb patterns, nuclear enlargement, high N/C ratio (1:4), anisonucleosis, irregular nuclear membrane, prominent nucleoli and conspicuous eosinophilic cytoplasm. The background showed necroinflammtory debris.

Diagnosis
Pancreatic Head Mass, EUS FNB Cytology (Smears and Cores):
Invasive adenocarcinoma, grade II, consistent with pancreatic duct origin.

Comment:
Please tightly correlate with clinical and radiological findings.

Ahmed El-Habashi, MD, FIAC

10 شارع صبرى أبو علم بجوار وزارة الاوقاف – باب اللوق – القاهرة
تليفون : 23929937 موبايل : 0166736608
E-Mail: elhabashiahmed@yahoo.com